

УДК: 616.24-006.6-771 (574)

К.Ш.Нургазиев*, А.А.Шортанбаев, Н.Т.Балтабеков**, А.С.Ракишева, А.К. Туманова*

*Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

**Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии МЗ РК

Новые подходы к иммунотерапии с использованием надерина при социально значимых заболеваниях, включая рак молочной железы, туберкулез, гепатит С

Грант КазНМУ - 2013

Аннотация. Работа посвящена профилактике иммунодефицита и лейкопении при лечении рака молочной железы, туберкулеза и гепатита С с использованием новых подходов иммунотерапии

За счет регулярного контроля иммунологического статуса возможно своевременное выявление осложнений базисной терапии в онкологии, фтизиатрии, гепатологии и возможность проведения профилактической, а не лечебной иммунотерапии с большей эффективностью, чем при появлении клинических признаков иммунодефицита на фоне выраженной лейкопении и резкого снижения иммунитета.

Использование новых подходов к иммунотерапии позволит повысить эффективность противоопухолевой химиотерапии в онкологии в среднем на 20-25%, увеличить безрецидивный период на 15-20 %, снизить затраты государства на иммунотерапию почти в 7 раз.

Ключевые слова: рак молочной железы, туберкулез, гепатит С, лейкопения, иммунодефицит.

Актуальность

Злокачественные новообразования, туберкулез, вирусный гепатит В относятся к социально значимым заболеваниям как в Казахстане так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так в нашей стране ежегодно выявляется около 30тыс. новых случаев онкологических заболеваний и ежегодно умирает более 15тыс. человек. Средний возраст пациентов составляет 55-60 лет

В то же время среди лиц молодого возраста в Казахстане существенную роль в структуре инвалидизации и смертности играет туберкулез легких и вирусные гепатиты. Малоизученной стороной течения этих заболеваний является влияние изменения состояния иммунной системы, влияние ее на прогноз заболевания и результаты лечения. Важным моментом послужившим поводом для данного исследования является отсутствие стандартов по коррекции иммунологических осложнений, возникающих в процессе противоопухолевой, противовирусной, антибактериальной, противотуберкулезной терапии

К иммунологическим осложнениям, возникающим в

процессе лечения данной группы пациентов относятся лейкопения, тромбоцитопения и вторичный клеточный иммунодефицит. Наличие данных осложнений является причиной резкого ухудшения качества жизни больных, приводит к прогрессированию основного заболевания и значительно ухудшает прогноз лечения. Важным моментом является тот факт, что существующий на сегодняшний день стандартные методы борьбы с этими осложнениями являются очень дорогостоящими, токсичными, обладающие кратковременным действием и не нашедшие широкого применения в практической медицине.

Основные идеи проекта заключаются в следующих положениях:

- иммунодефицит значительно ухудшает эффективность и прогноз лечения, а также качество жизни пациентов со злокачественными образованиями, туберкулезом и гепатитом В;

- для проведения иммунотерапии необходим четкий контроль за состоянием иммунологического статуса в процессе базисного лечения с целью своевременной профилактики возможных осложнений;

- применение препаратов нуклеиновых кислот позволит повысить эффективность иммунотерапии и базисной терапии, снизить токсичность противоопухолевой и противовирусной терапии и повысить качество жизни пролеченных больных.

Научная новизна проекта

Предпосылки к разработке. По литературным данным (Мирошник О.А., 2002) активное использование иммунотерапии началось в семидесятых годах XXв., когда получила признание иммунологическая теория происхождения злокачественных опухолей и была продемонстрирована возможность восстановления иммунологических показателей у онкологических больных при использовании ряда препаратов (Мирошник О.А., 2002). В 2002 году во Франции в городе Канн на VIII Международном конгрессе по иммунореабилитации В.П.Кузнецов высказал мнение, что несмотря на более 30-летний опыт использования самостоятельной иммунотерапии в онкологии наиболее перспективным направлением является совместное использование базисной противоопухолевой терапии и иммунопрепаратов как вспомогательного компонента для

улучшения переносимости противоопухолевой химио- или лучевой терапии, а также повышение качества жизни больных во время лечения.

Так О.А. Мирошник считает, что иммунологическое обследование и первичную иммунокоррекцию необходимо проводить у каждого онкологического больного, получающего химио- или лучевую терапию. По мнению автора противоопухолевое лечение подавляет иммунитет больного и требует пожизненного мониторинга состояния иммунной системы и его соответствующей коррекции. Поданным ЭСМО стандартным методом коррекции лейкопении и иммунодефицита является использование препаратов, восстанавливающих лейкопоз- колониостимулирующие факторы - нейпоген, граноцит, филгрозин.

Научная новизна. В данном исследовании впервые на достаточно большом клиническом материале - более 400 больных будет прослежено динамика показателей клеточного иммунитета в процессе лечения.

Впервые планируется выявить связь между изменениями иммунитета и течением основного заболевания у больных со злокачественными новообразованиями, туберкулезом и гепатитом В. Впервые планируется определить эффективность использования препаратов нуклеиновых кислот в качестве иммунокорректирующего лечения.

Впервые планируется индивидуализировать тактику противотуберкулезного, противовирусного и противоопухолевого лечения с учетом уровня иммунной системы.

Использование новой методики позволит повысить качество жизни больных, увеличить эффективность и переносимость лечения.

В случае положительного результата идеи данного проекта могут послужить поводом для международных совместных исследований с медицинскими университетами ближнего и дальнего зарубежья.

Экономический эффект данного исследования достаточно существен, так как позволит снизить затраты на иммунокорректирующую терапию почти в семь раз по сравнению с существующими схемами иммунокоррекции Казахстана и Европейской ассоциации онкологов.

Принципиальные отличия данного проекта от предыдущих

Впервые определяется динамика иммунитета в процессе лечения злокачественных новообразований, туберкулеза и гепатита В.

Впервые будет определено влияние изменений иммунитета на течение этих заболеваний.

Впервые будет определена эффективность дополнительной иммунокоррекции с учетом иммунологического статуса у пациентов с туберкулезом, гепатитом В и злокачественными новообразованиями.

Впервые в качестве иммунокорректирующего препарата в онкологии, фтизиатрии и гепатологии будет использоваться натрий содержащие соли нуклеиновых кислот вместо стандартных колониостимулирующих факторов.

Ожидаемые результаты

Данное исследование за счет регулярного контроля иммунологического статуса позволит своевременно выявлять осложнения базисной терапии в онкологии, фтизиатрии, гепатологии и проводить профилактическую, а не лечебную иммунотерапию с большей эффективностью, чем при появлении клинических признаков иммунодефицита на фоне выраженной лейкопении и резкого снижения иммунитета.

Использование новых подходов к иммунокоррекции позволит повысить эффективность противоопухолевой химиотерапии в онкологии в среднем на 20-25%, увеличить безрецидивный период на 15-20 %, снизить затраты государства на иммунокоррекцию почти в 7 раз.

В фтизиатрии новая методика может снизить сроки лечения на 25- 30 %. уменьшить затраты на терапию в среднем на 35-40 %. При лечении гепатита С данное исследование позволит увеличить переносимость и эффективность противовирусной терапии интерфероном альфа на 30 %, провести лечение тем, больным, имеющим противопоказания к базисной терапии, составляющим до 15 % контингента.

Список литературы

- 1 Кузнецов В.П., Кошенкова О.А., Беляев Д.А. Процентное соотношение общих иммуноглобулинов как важный критерий иммунологического статуса // Материалы VIII международного конгресса иммунореабилитации (Канны, Франция; 21-24 апреля 2002 год) – 2002 – С.77
- 2 Тюляндин С.А., Моисеев В.М. Практическая онкология: избранные лекции. - СПб: Центр Томм, 2004. – 782с.

Тұжырым

Қ.Ш.Нұрғазиев, А.А.Шортанбаев, Н.Т.Балтабеков, А.С.Рақышева, А.К.Тұманова

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Әлеуметтік орыны бар аурулар арасында сүт безі қатерлі ісігі, туберкулез, гепатит С, ауруларын надерінді қолдану иммунотерапиясының жаңа мүмкіндіктері. Грант ҚазФМҰ – 2013 жс.

Жұмыс иммунитет тапшылығына және лейкопенияға профилактика жүргізуге арналған, сүт безі қатерлі ісігін емдеу, туберкулез және гепатит С ауруларына иммунокоррекциялар жүргізудің жаңа мүмкіндіктері.

Иммунологиялық жағдайды үнемі бақылаудың арқасында заманауи пайда болған асқынуларды базисті терапияны онкологияда, фтизиатрияда және гепатологияда профилактика жүргізуге мүмкіндік береді, үлкен әсерлі иммунотерапиялық емдеуде емес, клиникалық иммунитет тапшылығының пайда болуына қарағанда лейкопенияның көбеюіне байланысты иммунитет тез арада төмендейді. Онкологияда иммунокоррекцияның жаңа мүмкіндіктерін пайдалану қатерлі ісікке қарсы химиотерапияның орта есеппен 20-25% әсерін жоғарлатты, қайта өршімейтін 3н аралықты 15-20% көбейтті, иммунокоррекциялық мемлекеттік шығынды 7 есеге дейін азайтты.

Түйінді сөздер: иммунотерапия, иммунокоррекция, қатерлі ісіктер.

Summary

K. S. Nurgaziev, A. A. Shortanbaev, N. T. Baltabekov, A. S. Rakisheva, A. K. Tumanova

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Kazakh National Medical University im. S. D. Asfendiyarova
New approaches to immunotherapy using naderrin as socially

significant diseases, including breast cancer , tuberculosis, and hepatitis C.

Grant KazNMU 2013

The thesis prevention of immunodeficiency and leukopenia in the treatment of breast cancer, tuberculosis and hepatitis C using new approaches immunocorrection.

The regular monitoring of the immunological status may timely detection of complications of basic therapy in oncology, tuberculosis, Hepatology and the possibility of preventive rather than curative immunotherapy with greater

efficiency than with clinical signs of immunodeficiency on the background of severe leukopenia and a sharp decline in immunity.

New approaches to immunomodulation will increase the efficiency of anticancer chemotherapy in cancer by 20-25 %, increase the disease-free period by 15-20%, reduce the cost to the state immunocorrection almost 7 times.

Keywords: immunotherapy, naderin, breast cancer, immunodeficiency, leukopenia, immunocorrection.